

Fecha Última Actualización: 18-05-2023 1:16:03

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Alcides Antonio Tejos Diaz
Edad : 56a 9m 8d
Dirección : F De Quevedo 478 P Las Brisas

Rut : 10.725.156-1
Fecha Nacto: 10/08/1966
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A701865
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7851 7903

N° Epicrisis
338591

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utac/ Utinx

Fecha Ingreso : 21/01/2023 14:50

Días Estadía: 117

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 18/05/2023 01:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hemiparesia izquierda

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

DIAGNOSTICOS

Manejo de fin de vida

Sd febril ITU obs bacterémica por K pneumoniae BLEE (S) Imipenem

Crisis convulsiva reactiva (10/05)

- Epilepsia secundaria Obs RAM a carbapenemico

ACV isquémico cardioembólico de territorio de ACM D°

- Transformación hemorrágica post trombolisis química + trombectomía mecánica M1 D°

- Craniectomía descompresiva 23-01 por HTE, colección de sitio Qx

FA RVR

Traqueostomía quirúrgica 03/03/23

HTA

LPP sacra G3

Resueltas:

·Bacteriemia por E. cloacae.

·Neumonía asociada a ventilación mecánica por K. pneumoniae BLEE.

·ITS CVC bacterémica S epidermidis 4/3

·NAVM Klebsiella pneumoniae BLEE 3/3/23

·ITU Klebsiella pneumoniae BLEE + Proteus vulgaris/penneri/hausen 3/3/23.

·Traqueobronquitis por Klebsiella BLEE.

·Bacteriemia por Klebsiella Pneumoniae + Enterococcus Faecium Van B.

Infección asintomática por SARS COV-2 21/01.

IAM S/SDST

Delirium hiperactivo

Resumen: paciente neurocrítico en malas condiciones generales determinada por sepsis de multiples focos intatrabale dada microbiología resistente y RAM grave a antibioticoterapia. Malo pronóstico a corto, mediano y largo plazo, por lo que se inicia manejo de fin de vida. Paciente conocido, en manejo de fin de vida. Se mantiene en malas condiciones generales, hipotenso, taquicardico, afebril, sin taquipnea y con requerimientos de oxígeno por TQT.

Fecha Epicrisis : 18/05/2023 01:16

Página 1 de 2

PLANES POR SISTEMAS

HDN: Estable. MNI.

Respiratorio: Con insuficiencia respiratoria moderada, polipneico con bajos requerimientos de O2 por TQT. Se mantiene BD y se ajusta dosis de morfina para manejo de disnea.

Neurología: Con epilepsia secundaria, se mantienen FAEs. En caso de crisis de > 2min, administrar lorazepam 2mg i.v. (puede indicarse máximo 4mg por 2 veces en caso que no yugule).

Infeccioso: cursando ITU x Klebsiella BLEE, de momento afebril por manejo con antipiréticos.

Manejo: Hasta sala, no DVA, no RCP, no TOT, no ATB

Diagnóstico de Egreso

Accidente vascular isquémico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Se constata fallecimiento 00:51 am

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo : Cabeza Línea Media 30°

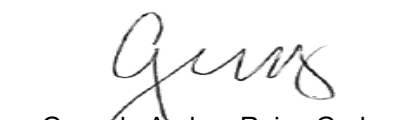
Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles



Javier Andronico Madariaga Olivos
INTERNO



Gonzalo Andres Rojas Godoy
Becado/Residente



Fernando Araya Rojas
Médico Tratante (Staff)